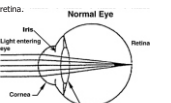


Introduction
This patient information leaflet is designed to help you decide whether you want to have an Implantable Phakic Contact Lens (IPL V2.0) placed in one or both eyes to correct your nearsightedness (myopia) or farsightedness (hyperopia). It is important to understand the benefits and possible risks before making your decision. Please read this leaflet carefully and discuss any questions with a doctor trained in IPL V2.0 surgery.

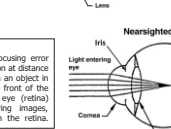
What Is Nearsightedness and Farsightedness?

NORMAL EYE
Light focuses on the retina. Vision is clear.



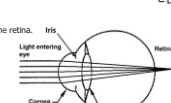
NORMAL EYE
Your eye works like a camera. You see objects because your eye focuses light into images. Both the clear front layer of your eye, called the cornea, and your natural crystalline lens focuses rays of light onto the back surface of the eye, called the retina.

NEARSIGHTED EYE
Light focuses in front of the retina. Vision is blurry.



NEARSIGHTED EYE
Your eye works like a camera. You see objects because your eye focuses light into images. Both the clear front layer of your eye, called the cornea, and your natural crystalline lens focuses rays of light onto the back surface of the eye (retina) responsible for capturing images rather than directly on the retina.

FARSIGHTED EYE
Light focuses behind the retina. Vision is blurry.

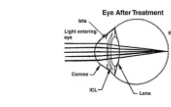


FARSIGHTED EYE:
Farsightedness (hyperopia) is a common vision condition in which you can see distant objects clearly, but objects nearby may be blurry.

Glasses and contact lenses can help your eye focus light properly on the retina. The IPL V2.0 can also help your eye focus light properly on the retina.

How Does IPL V2.0 Correct Nearsightedness and Farsightedness?

CORRECTION OF VISION AFTER IPL V2.0 SURGERY

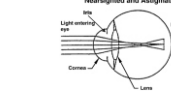




A diopter (D) is a unit used to measure how well your eye can see. It shows the level of nearsightedness, farsightedness, or astigmatism you may have. IPL V2.0 surgery can treat nearsightedness from -0.5 D to -15.0 D and farsightedness from +0.5 D to +15.0 D. If your vision falls within these ranges, this surgery may help you see clearly without glasses or contact lenses.

The IPL V2.0 monofocal lens does not correct astigmatism. Astigmatism is a common vision problem that causes blurred or uneven vision. It happens when the front surface of the eye (cornea) is not evenly shaped. Because of this, light does not focus properly inside the eye, and some parts of what you see may look clearer than others.

NEARSIGHTED AND ASTIGMATIC EYE





IPL V2.0 Toric / IPL V2.0 Presbyopic Toric can correct any astigmatism you have up to +1.0 D to +10D. You are requested to consult your doctor to choose appropriate suitable options for your eye.

Choosing the best lens for your vision

There are different types of lenses available. Your eye doctor will help you choose the one that is best for you. Other treatment options include glasses with thick lenses or contact lenses instead of a permanent lens implant. Talk to your eye doctor about the benefits and possible risks of each option.

Other Treatments to Correct Nearsightedness and Farsightedness ?
Other treatments to correct nearsightedness and farsightedness include eyeglasses, contact lenses, and refractive surgical procedures. Surgical options include Photorefractive Keratectomy (PRK), Laser-Assisted in Situ Keratomileusis (LASIK), refractive lens exchange (RLE), and phakic intraocular lens implantation (e.g., IPL V2.0). However, these procedures may not meet the visual requirements for certain professions, such as military service.

These procedures either reshape the cornea or place a lens inside the eye. PRK and LASIK use a laser to reshape the shape of the cornea so the eye can focus better. In LASIK, a thin flap of the cornea is lifted, the laser reshapes the tissue underneath, and the flap is put back in place to heal. Phakic intraocular lens implantation, like IPL V2.0, adds an artificial lens inside the eye without removing any natural lens.

Benefit And Risks of the IPL V2.0

IPL V2.0 surgery can safely correct nearsightedness between -0.5D to -15D and farsightedness between +0.5D to +15D. If your eyeglass prescription is in these ranges, the IPL V2.0 may make your distance vision without eyeglasses or contact lenses. Implanting IPL V2.0 requires eye surgery which carries potential risks. Please read this leaflet carefully and talk to your doctor about the possible risks.

- Few of the risks are as below**
 - Additional surgery
 - Sometimes, a second surgery may be needed to remove, replace, or adjust the IPL V2.0. It may need to be removed during cataract surgery. Additional surgery might also be needed to reduce eye pressure.
 - Cataract formation
- After Phakic IOL surgery, there is an increased risk that the natural lens of your eye may become cloudy, leading to cataracts that could require surgery. The longer the IPL V2.0 stays in the eye, the higher this risk becomes. Regular eye exams, including IPL V2.0, can cause additional loss of these cells. If too many cells are lost, the cornea can become cloudy and affect your vision. Before surgery, your doctor will examine your eyes to check if you are suitable for IPL V2.0. After the IOL and the cloudy lens are removed, and the long-term is implanted, just like routine cataract surgery.
- Loss of Best Corrected Vision (BCVA)
- The most common reason was clouding of the natural lens (cataract). Vision may get better in these eyes after cataract surgery.
- Raised pressure inside the eye or damage to the optic nerve caused by increased pressure in eye (Glaucoma)
- Normal eye pressure (intraocular pressure or IOP) can vary but is often considered to be from 10-21 millimeters of mercury (mmHg). An IOP higher than normal is called ocular hypertension and if left untreated, can cause damage to the optic nerve and cause permanent vision loss.

Endothelial Cell Loss
The cornea is the clear front part of your eye(s) has a thin layer of special cells called endothelial cells. These cells keep the cornea clear by removing extra fluid. Normally, the number of these cells slowly decreases with age. Eye surgery, including IPL V2.0, can cause additional loss of these cells. If too many cells are lost, the cornea can become cloudy and affect your vision. Before surgery, your doctor will examine your eyes to check if you are suitable for IPL V2.0. After the cornea (called corneal edema), which may require a cornea transplant.

- Other Complications**
 - Other risks associated with IPL V2.0 surgery may include:
 - movement of the colored portion of the eye (iris) through a surgical wound to a position outside the eye (iris prolapse)
 - bleeding in the area on the retina responsible for reading vision (macular hemorrhage),
 - bleeding under the retina (subretinal hemorrhage),
 - increasing in focusing near (accommodation),
 - lifting or pulling of the retina from its natural position (retinal detachment),
 - unequal pupil size (anisocoria).

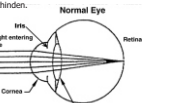
Adverse reactions and complications due to, or following surgery and implication of any implantable Phakic Contact Lens may include, but are not limited to:

- Increased astigmatism
- Refraction error
- Intraocular infection
- Vitrealous loss
- Visualizing issue
- Anterior subcapsular cataract
- Severe intraocular inflammation
- Glaucoma
- Secondary glaucoma
- Uveitis
- Vitritis
- Hyphema
- Hyphopyon
- Under/over correction
- Non-reactive pupil
- Endophthalmitis
- TASS
- Retinal Detachment
- Iritis
- Cystoid macular edema
- Macular edema

Introduktion
Denne patientinformationsbrochure er udsendt til dig til hjælp af dig med at beslutte, om du ønsker at få implanteret en Implantable Phakic Contact Lens (IPL V2.0) i det ene eller begge øjne for at korrigere din nærsynethed (myopi) eller langsynethed (hyperopi). Det er vigtigt at forstå fordelene og de mulige risici, før du træffer din beslutning. Læs denne brochure omhyggeligt, og drøft eventuelle spørgsmål med din læge, der er uddannet i IPL V2.0-kirurgi.

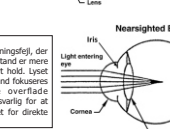
Hvad er nærsynethed og langsynethed?

NORMALT ØJE
Lysret fokuseres på nethinden. Synet er klart.



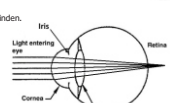
NORMALT ØJE:
Dit øje fungerer som et kamera. Du ser genstande, fordi øjet fokuserer lyset til billeder. Både den klare forreste del af øjet, kaldet hornhinden, og den naturlige øjenlinse fokuserer lyset præcist på øjets bagste overflade, kaldet nethinden.

NÆRSYNET ØJE
Lysret fokuseres foran nethinden. Synet er sløret.



NÆRSYNET ØJE
Nærsynethed er en brydningsfejl, der medfører, at synet på afstand bliver mere sløret end synet på nært hold. Lyset fra en genstand på afstand fokuseres foran øjets bagste overflade (nethinden), som er ansvarlig for at opfange billeder, i stedet for direkte på nethinden.

LANGSYNET ØJE
Lysret fokuseres bag nethinden. Synet er sløret.



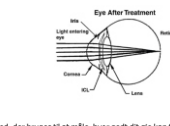
LANGSYNET ØJE:
Langsynethed (hyperopi) er en almindelig synsforstyrrelse, hvor du kan se fjerne genstande tydeligt, men genstande tæt på kan være slørede.

Slimslået og pilslået lys vil automatisk korrigeres af den naturlige linse i øjet. Hvis IPL V2.0 vil udtøjes slimslået korrigerende valen øjet i retning af retinale. Hvis IPL V2.0 vil udtøjes slimslået korrigerende valen øjet i retning af retinale.

Briller og kontaktlinser kan hjælpe dig med at fokusere lyset korrekt på nethinden. IPL V2.0 kan også hjælpe dig med at fokusere lyset korrekt på nethinden.

Hvordan korrigerer IPL V2.0 nærsynethed og langsynethed?

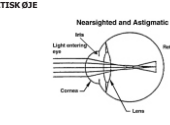
SYNKKORREKTION EFTER IPL V2.0-KIRURGI





En dioptri (D) er en måleenhed, der bruges til at måle, hvor godt dit øje kan fokusere. Den angiver graden af nærsynethed, langsynethed eller astigmatisme. IPL V2.0-kirurgi kan behandle nærsynethed fra -0.5 D til -15.0 D og langsynethed fra +0.5 D til +15.0 D. Hvis dit syn ligger inden for disse intervaller, kan denne operation hjælpe dig med at se klart uden briller eller kontaktlinser.

IPL V2.0-monofokallinse kan ikke korrigere astigmatisme. Astigmatisme er en almindelig synsfejl, der forårsager sløret eller ujævn syn. Det opstår, når øjets forreste overflade (hornhinden) ikke er jævnt formet. Derfor fokuseres lyset ikke korrekt inde i øjet, og nogle dele af det, du ser, kan fremstå tydeligere end andre.





IPL V2.0 Toric / IPL V2.0 Presbyopic Toric kan korrigerer astigmatisme fra +1.0 D op til +10.0 D. Du bedes rådføre sig med din øjenlæge for at vælge den mest egnete løsning til dig øje.

Valg af den bedste linse til dit syn
Der findes forskellige typer linser. Din øjenlæge vil hjælpe dig med at vælge den linse, der passer bedst til dig. Andre behandlingsmuligheder omfatter briller med tykke glas eller kontaktlinser i stedet for et permanent linseimplantat. Tal med din øjenlæge om fordelene og de mulige risici ved hver behandlingsmulighed.

Andre behandlinger til korrektion af nærsynethed og langsynethed
Andre behandlinger til korrektion af nærsynethed og langsynethed omfatter briller, kontaktlinser og refraktive kirurgiske procedurer. Kirurgiske muligheder omfatter Photorefractive Keratectomy (PRK), laser-assisteret in situ keratomileusis (LASIK), refraktiv linseudveksling (RLE), og implantation af en fakisk intraokulær linse (fakisk IPL V2.0). Disse procedurer opfylder dog muligvis ikke synskravene for visse erhvervs, såsom militærtjeneste.

Disse procedurer omfatter enten hornhinden eller placeringen en linse inde i øjet. PRK og LASIK anvender en laser til at ændre hornhinnens form, så øjet kan fokusere bedre. Ved LASIK læftes en tynd flap af hornhinden, læsner omformer vævet under, og flappen sættes tilbage i plads. I LASIK, en tynd flap af hornhinden, læsner omformer vævet under, og flappen sættes tilbage i plads. I LASIK, en tynd flap af hornhinden, læsner omformer vævet under, og flappen sættes tilbage i plads. I LASIK, en tynd flap af hornhinden, læsner omformer vævet under, og flappen sættes tilbage i plads.

Fordele og risici ved IPL V2.0
IPL V2.0-kirurgi kan sikkert korrigere nærsynethed fra -0.5 D til -15 D og langsynethed fra +0.5 D til +15 D. Hvis din brillepreskription ligger inden for disse intervaller, kan IPL V2.0 forbedre dit afstandsyn uden behov for briller eller kontaktlinser. Implantation af IPL V2.0 kræver øjenkirurgi, som indebærer potentielle risici. Læs denne brochure omhyggeligt, og tal med din læge om de mulige risici.

- Mutamide risikoen er beskrevet nedenfor**
 - Yderligere kirurgi
 - I nogle tilfælde kan en anden operation være nødvendig for at fjerne, udskifte eller justere IPL V2.0. Den kan også være nødvendig for at fjerne IOP-fortrængelse med en grå star-operation. Yderligere kirurgi kan også være nødvendig for at reducere tryk i øjet.
 - Udvikling af grå star
- Efter implantation af en fakisk intraokulær linse er der en øget risiko for, at øjets naturlige linse bliver uklart, hvilket kan føre til grå star. Som kan kræve operation for at fjerne. Jo længere IPL V2.0 forbliver i øjet, desto større bliver denne risiko. Regelmæssige øjenundersøgelser er vigtige for at kontrollere for udvikling af grå star. Ældre patienter og personer med høj grad af nærsynethed eller langsynethed kan have en større risiko. Den langsigtede risiko ud over 7 år er ukendt. Hvis en operation for grå star bliver nødvendig, fjernes både IPL V2.0 og den uklare naturlige linse, hvorefter en ny linse implanteres på samme måde som ved en rutinemæssig operation for grå star.
- Tab af bedst korrigeret synstærke (BCVA)
- Den hyppigste årsag var uklare af den naturlige linse (grå star). Synet kan forbedres i disse øjne efter en operation for grå star.
- Forhøjet tryk i øjet og beskadigelse af synsnerven forårsaget af forhøjet tryk i øjet (glaukom)
- Normal øjetryk (intraokulært tryk eller IOP) kan variere, men anses generelt for at ligge mellem 10 og 21 millimeter kviksølv (mmHg). Et højt øjetryk over normalt kaldes økt øjetryk og kan være en risikofaktor for glaukom. Hvis der mistes for mange celler på synsnerven (glaukom) og/eller til permanent synstap.

Tab af endotheliale celler
Hornhinden (den klare forreste del af øjet) har et tyndt lag af specialiserede celler, der kaldes endotheliale. Disse celler holder hornhinden klar ved at fjerne overflødig væske. Normalt falder antallet af disse celler langsomt med alderen. Øjenkirurgi, herunder implantation af IPL V2.0, kan medføre yderligere tab af disse celler. Hvis der mistes for mange celler, kan hornhinden blive uklart og påvirke dit syn. For operationen vil du ligge under en lase operation, der er udtøjet, om du er egnet til IPL V2.0. Efter operationen kan et grå star opstå af disse celler. Hvis der mistes for mange celler, kan der opstå problemer i hornhinden (kaldet hornhindeødem), hvilket kan gøre en hornhindeimplantation nødvendig.

- Andre komplikationer**
 - Andre risici forbundet med IPL V2.0-kirurgi kan omfatte:
 - forvridning af den fargede del af øjet (iris) gennem operationsområdet til en position uden for øjet (irisprolaps),
 - blødning i det område af nethinden, der er ansvarlig for læsesynet (makulablodning),
 - blødning under nethinden (subretinal blødning),
 - øget brydningsfejl (astigmatisme),
 - lønning eller trækning af nethinden fra dens naturlige position (nethinde løsning),
 - ulig pupill størrelse (anisocori).

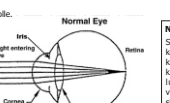
Bivirkninger og komplikationer som følge af eller efter kirurgi og implantation af en implantable Phakic Contact Lens kan omfatte, men er ikke begrænset til:

- Øget astigmatisme
- Brydningsfejl
- Intraokulær infektion
- Tab af glauceme
- Problem med vasking
- Forreste subkapulære katarakt
- Alvorlig intraokulær inflammation
- Glaukom
- Sekundært glaukom
- Uveitis
- Vitritis
- Hyphema
- Hyphopyon
- Underkorrigering/overkorrigering
- Non-reaktiv pupil
- Endophthalmitis
- TASS
- Vitrealvævsdetachment
- Iritis
- Cystoid maculær ødem
- Maculær ødem

Johdanto
Tämä potilastieto lehtinen on laadittu auttamaan sinua päättämässä, haluatko, että toisen tai molempin silmää asennetaan Implantable Phakic Contact Lens (IPL V2.0) lähinäkösi (myopia) tai kaukonäkösi (hyperopia) korjaukseen. On tärkeää ymmärtää hyödyt ja mahdolliset riskit ennen päätöksen tekemistä. Lue tämä lehtinen huolellisesti ja keskustele lääkärisi kanssa, jos sinulla on kysyttävää IPL V2.0-kirurgian koulutusta sisältävällä kaksiosaisella.

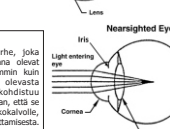
Mitä ovat lähinäköisyys ja kaukonäköisyys?

NORMAALI SILMÄ
Valo kohdistuu verkkokalvolle. Näkö on selkeä.



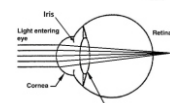
NORMAALI SILMÄ:
Silmä toimii kuin kamera. Näet kohteet, koska silmäsi kohdistaa valon oikealle kohdalle. Sen silmän kirkas etuosa, jota kutsutaan sarveiskalvoksi, että luonnollinen mykiä kohdistavat valon säteet silmän takaosassa sijaitsevalle verkkokalvolle.

LÄHINÄKÖINEN SILMÄ
Valo kohdistuu verkkokalvon eteen. Näkö on sumea.



LÄHINÄKÖINEN SILMÄ
Lähinäköisyys on taittovirhe, joka aiheuttaa sen, että kaukana olevat kohteet näkyvät epätarkasti, kun taas lähellä olevat kohteet näkyvät selvästi. Kaukana olevat kohteet tulevat valon kohdistuu verkkokalvon eteen sijasta, että se kohdistuu suoraan verkkokalvolle, joka vastaa kuvan vastaanottamisesta.

KAUKONÄKÖINEN SILMÄ
Valo kohdistuu verkkokalvon taakse. Näkö on sumea.



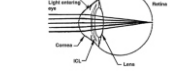
KAUKONÄKÖINEN SILMÄ:
Kaukonäköisyys (hyperopia) on yleinen näkövika, jossa kaukana olevat kohteet näkyvät selvästi, mutta lähellä olevat kohteet voivat näkyä sumeina.

Silmästä ja pilkista valot automaattisesti korrigeerataan valon oikein verkkokalvolle. Myös IPL V2.0 voi auttaa silmääsi korrigeeramaan valon oikein verkkokalvolle.

Brillit ja kontaktinset kan hjælpe øyet med at fokusere lyset rigtig på nethinden. IPL V2.0 kan også hjælpe øjet med at fokusere lyset rigtig på nethinden.

Miten IPL V2.0 korjaa lähinäköisyyttä ja kaukonäköisyyttä?

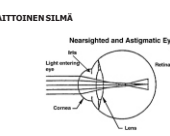
NÄÖN KORJAUS IPL V2.0 -LEIKKAUKSEN JÄLKEEN





Dioptri (D) on mittayksikkö, jota käytetään mittaamaan silmän tarkennuskykyä. Se osoittaa lähinäköisyyden, kaukonäköisyyden tai astigmatismia. IPL V2.0-leikkauksella voidaan hoitaa lähinäköisyyttä välillä -0.5 D – -15.0 D ja kaukonäköisyyttä välillä +0.5 D – +15.0 D. Jos näkösi on näiden arvojen sisällä, tämä leikkaus voi auttaa sinua näkemään selvästi ilman silmälasia tai piilolinssiä.

IPL V2.0-monofokaalinen linssi ei korjaa astigmatismia. Astigmatismi on yleinen näköhäiriö, joka aiheuttaa sumeaa tai epätasalaista näköä. Se johtuu siitä, että silmän etupinta (sarveiskalvo) ei ole tasainen muotoon. Tämän seurauksena valo ei kohdistu oikein silmän sisällä, ja osa näkösi voi näyttyä tarkemmalta kuin muu osa.





IPL V2.0 Toric / IPL V2.0 Presbyopic Toric voi korjata fakiskasta astigmatismia välillä +1.0 D to +10.0 D. Pyydymme sinua keskustelemaan lääkärisi kanssa silmälasei parhaiten soveltuvan vaihtoehdon valitsemiseksi.

Parhaan silmän valitsemisen näkötila varten
Säätävien on erilaisia tyyppisiä silmiä. Silmälääkärisi auttaa sinua valitsemalla sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon. Mutta halotavoitteenasi ovat kaukonäköisyyttä silmälasei pilkistämisen, jotta silmäsi näkisivät selkeästi. Keskustele silmälääkärisi kanssa kunkin vaihtoehdon hyödyt ja mahdolliset risikit.

Muita hoitovaihtoehtoja lähinäköisyyden ja kaukonäköisyyden korjaukselle
Korjaavien vaihtoehtoja ovat Photorefractive Keratectomy (PRK), Laser-Assisted in Situ Keratomileusis (LASIK), refraktiivinen linssi vaihto (RLE) ja fakiskin silmänsisäisen linssin implantoit (esim. IPL V2.0). Näistä toimenpiteistä eivät kuitenkaan välttämättä täytä tiettyjen ammattien, kuten asetaluvalvojen, vaatimusten.

Nämä toimenpiteet joko muuttavat sarveiskalvon muotoa tai asettavat silmän silmän sisään. PRK- ja LASIK-toimenpiteissä käytetään laseria sarveiskalvon muodon muuttamiseen, jotta silmä pystyy tarkentamaan paremmin. LASIK-toimenpiteessä sarveiskalvosta nostetaan ohut kappale, laser muuttaa sen alla olevan kudoksen, ja kappale asetetaan takaisin paikalleen parantamista varten. Fakiskin silmänsisäisen linssin implantoit, IPL V2.0, lisää keinotekoisin silmän sisään postistausta luonnollista silmää.

IPL V2.0:n hyödyt ja riskit
IPL V2.0-leikkauksella voidaan hoitaa lähinäköisyyttä välillä -0.5 D – -15 D ja kaukonäköisyyttä välillä +0.5 D – +15 D. Jos silmänsisäisen kysymys kuuluu näihin arvoihin, IPL V2.0 voi parantaa kaukonäköäsi ilman silmälasia tai piilolinssiä.

IPL V2.0:n implantoitua edellyttää silmälääkärisi, johon liittyy mahdollisia risikoita. Lue tämä lehtinen huolellisesti ja keskustele lääkärisi kanssa mahdollisista risikoista.

- Mutamide risikoen on kuvattu alla**
 - Lisäleikkaukset
 - Jotkut voidaan tarvitta toistaa leikkaukset IPL V2.0:n poistamiseksi, vaihtamiseksi tai säätämiseksi. Se voidaan joutua postistausta kateikkauksia yhteydessä. Lisäleikkaukset voi olla tarpeen myös silmänpaineen alentamiseksi.
 - Kalvin muodostuminen
- Fakiskin IOL-leikkauksella jätteen on lisäsynnyn riski, että silmäs luonnollinen linssi sammutuu, mikä johtaa katarakti, joka voi vaatia leikkauksia. Mää pitempään IPL V2.0 pysyy silmässä, sitä suuremmalla, tämä riski kasvaa. Säännölliset silmälääkäriset ovat tärkeitä kalvin tarkistamiseksi. Tästäkin potilailla ja henkilöillä, joita on voimakas lähinäköisyys tai kaukonäköisyys, voi olla suurempi riski. Pääasiassa riski 7 vuoden jälkeen ei tunneta. Jos kateikkauksella on tarpeen, IPL V2.0 ja samaa linssi postistausta ja vain linssi asennetaan, alkanen tunnin ruutiinoinnissa kateikkauksessa.
- Parhaan korjauksen näöntarkkuuden (BCVA) heikkeneminen
- Yleisin syy oli luonnollisen mykiä sammutuminen (kalvi). Näkö voi parantua näissä silmissä kateikkauksen jälkeen.
- Kohonnut silmänpaine ja kohonnut silmänpaineen aiheuttama näköhäiriön vaurio (glaukoma)
- Normaal silmänpaine (intraokulaarinen paine tai IOP) vaihtelee, mutta sen tasokanta yleensä oleva 10-21 millimetriä kateikkauksella (mmHg). Normaalka korkeampi IOP-arvo kutsutaan okulaariseksi hypertensioiksi, ja hoitamattomana se voi vaurioittaa näkönsä (glaukoma) ja aiheuttaa pysyvän näköhäiriön.

Endoteelien solujen menetykset
Säätävien solujen (silman kirkas etuosa) on ohut kerros erityisiä soluja, jotka kutsutaan endoteelisoliksi. Nämä solut pitävät silmälääkettä kirkkaana postistausta ylläpitämällä nestettä. Tavallisesti näiden solujen määrä vähenee iästäsi in myötä. Silmälääkärisi, mukaan lukien IPL V2.0, voi aiheuttaa näiden solujen isäntämyötä. Jos soluja menetetään liikaa, sarveiskalvo voi sammutua ja heikentää näköä. Ennen leikkauksia lääkärisi tutkii silmäs valmistautumiseen, että IPL V2.0 soveltuu sinulle. Leikkauksen jälkeen näiden solujen menetyk voi jatkua ajan myötä. Jos soluja menetetään liikaa, sarveiskalvo voi kertyä nestettä (sarveiskalvon turvotus), mikä voi edellyttää sarveiskalvonleikkauksia.

- Muut komplikaatiot**
 - Mutta IPL V2.0-leikkauksen liittyy riskit voivat olla:
 - forvridning af den fargede delen af øjet (iris) gennem operationsområdet til en position udenfor øjet (irisprolaps),
 - blødning under nethinden (subretinal blødning),
 - øget brydningsfejl (astigmatisme),
 - løsnning eller vækning af nethinden fra dens naturlige position (nethindevækning),
 - ulig pupillstørrelse (anisocori).

Implantation af Implantable Phakic Contact Lens -linssin aiheuttamia tai leikkauksen aikana tai sen jälkeen ilmeneviä halitavauksia ja komplikaatioita voivat olla muun muassa seuraavat:

- Økt astigmatisme
- Brytningfeil
- Intraokulær infeksjon
- Glaukome tap
- Problem med vasking
- Forreste subkapulære katarakt
- Alvorlig intraokulær betennelse
- Glaukom
- Sekundært glaukom
- Uveitt
- Vitritt
- Hyphema
- Hyphopyon
- Underkorrigering/overkorrigering
- Ikke-reaktiv pupil
- Endfalmitt
- TASS
- Nethindevækning
- Ikke-reaktiv pupil
- Cystoid makulødem
- Nakulødem
- Dekompensasjon av hornhinnen

Indledning
Denne patientinformasjonsbrochure er utarbeidet for å hjelpe deg med å avgjøre om du ønsker å få implantert en Implantable Phakic Contact Lens (IPL V2.0) i ett eller begge øyne for å korrigere nærsynethet (myopi) eller oversynethet (hyperopi). Det er viktig å forstå fordelene og de mulige risikoene før du tar en beslutning. Les dette heftet nøyte og diskutér eventuelle spørsmål med en lege som er opplært i IPL V2.0-kirurgi.

Hva er nærsynethet og langsynethet?

NORMALT ØYE
Lysret fokuseres på nethinnen. Synet er klart.

